

Techniques de soins infirmiers — L1

Diapositive 1

SOMMAIRE (1/6)

CHAPITRE 1 :

SOINS INFIRMIERS GENERAUX

ACCUEIL

DU MALADE

VISITES

AUX

MALADES

CHAMBRE DU

MALADE

REPOS DU

MALADE

REFECTION

DU LIT DU

MALADE

Diapositive 2

SOMMAIRE

(2/6)

CHAPITRE

2

:

TECHNIQUES DE SOINS INFIRMIERS DE BASE EN MEDECINE ET EN
CHIRURGIE

SOINS INFIRMIERS DANS LA FONCTION DE
THERMOREGULATION

THERMOREGULATION

TEMPERATURE CORPORELLE ET THERMOMETRE
MEDICAL

FEUILLE DE
TEMPERATURE

VESSIE DE

GLACE

BOUILLOTTE

COUP DE

CHALEUR

INSOLATION.

Diapositive 3

SOMMAIRE

(3/6)

SOINS

INFIRMIERS DANS LA FONCTION

LOCOMOTRICE

PANSEMENTS

BANDAGES

IMMOBILISATIONS

PROVISOIRES

Diapositive 4

SOMMAIRE

(4/6)

SOINS

INFIRMIERS DANS FONCTION CARDIO-VASCULAIRE

MESURE

DES PULSATIONS OU

POULS

MESURE DE LA TENSION OU PRESSION

ARTERIELLE

INJECTIONS

PARENTERALES

INJECTION

INTRADERMIQUE

INJECTION SOUS

CUTANEE

INJECTION

INTRAMUSCULAIRE

INJECTION

INTRAVEINEUSE

INJECTION LENTE PAR DISPOSITIF INTRAVEINEUX

PRELEVEMENT

DE SANG PAR PONCTION

VEINEUSE

PERFUSION INTRAVEINEUSE

SECURITE DES INJECTIONS ET IMPACT DES INJECTIONS A

RISQUE

CALCUL DES DOSES ET POURCENTAGE DES

MEDICAMENTS

Diapositive 5

SOMMAIRE

(5/6)

SOINS

INFIRMIERS DANS LA FONCTION

URINAIRE

GENERALITES

RECUEIL DES URINES POUR

ANALYSE

SOINS INFIRMIERS DANS

LA

FONCTION

DIGESTIVE

CONTROLE ET EVACUATION

INTESTINALE

RECUEIL

ET SURVEILLANCE DES

SELLES

LES LAVEMENTS

EVACUATEURS

ET

MEDICAMENTEUX

Diapositive 6

SOMMAIRE

(6/6)

SOINS

INFIRMIERS DANS LA FONCTION

RESPIRATOIRE

AIDE A LA

VENTILATION

OXYGENOTHERAPIE

SOINS

INFIRMIERS DE

BASE

TOILETTE GENERALE DU

MALADE

SOINS DE L'ESCARRE OU L'ULCERE DE

DECUBITUS

SOINS D'HYGIENE DES CAVITES

NATURELLES

INSTALLATION ET DIVERSES POSITIONS DU MALADE DANS LE

LIT

Diapositive 7

L'ACCUEIL DU MALADE

INTRODUCTION

La réception d'un malade à l'hôpital est, pour l'agent de santé (INFAS), un fait quotidien. L'agent de santé doit faire de la réception du malade un élément important de son travail. Il doit tenir compte de la mentalité du patient et de ses parents.

Devant la crainte, l'inconnu, l'incertain, l'incertitude, la douleur de la séparation, l'attitude de l'agent de santé doit témoigner de compréhension, et créer une atmosphère de confiance et de sécurité ; Car la première impression peut influencer le bien être de tout le séjour du malade à l'hôpital.

Diapositive 8

DEFINITION

Qui dit

« accueil »

dit réception d'un hôte que l'on attend. L'hôte attendu c'est le malade auquel s'attache une psychologie toute spéciale empreinte de sensibilité extrême.

La

réception d'un malade est une activité qui consiste à recevoir une personne qui vient pour une consultation, un soin, ou une hospitalisation en vue de la mettre dans des conditions idoines au cours de son passage dans une structure sanitaire.

Diapositive 9

II- BUT

L'accueil a pour but

d'

amoindrir

, de

réparer,

de

soulager

en quelque sorte le mal causé par la maladie

(séparation familiale, la souffrance).

« C'est la première impression qui compte »

dit le langage populaire.

Le soignant doit alors donner une bonne impression au malade dès leur première rencontre. Un certain nombre de démarche est nécessaire pour que le malade se sente à l'aise. Le soignant a un rôle primordial dans l'accueil.

Diapositive 10

Le diagnostic infirmier

sera : un déficit de connaissances sur les problèmes liés à l'hospitalisation ou au mal causé par la maladie ; et le rejet de l'environnement sanitaire et/ou des soignants.

Les besoins à satisfaire sont :

apprendre

,

éviter les dangers

.

Diapositive 11

III- LE RÔLE

DE L'INFIRMIER OU DE LA SAGE

FEMME

Il est de plusieurs ordres

Le domaine administratif

L'infirmier ou la sage-femme

doit :

Diriger le malade et sa famille avec amabilité vers le service ou l'agent chargé des formalités administratives

Diriger

le malade vers

l'hospitalisation

Identifier

les personnes chargées de le prendre en

charge

Conseiller

pour

bien garder argent, bijoux ou

autres objets de valeurs

.

Diapositive 12

Le domaine Médical et de la surveillance

Prendre la température, les pulsations et parfois la respiration et inscrire (si possible) sur la feuille de température

L

e

p

eser

Lui indiquer où prendre les tubes d'examen ou les mettre à sa disposition

Noter les

observations

Prendre connaissance du

régime

Préparer le nécessaire pour l'examen médical ou la visite

.

Diapositive 13

Le domaine relationnel et
conseil

Indiquer au malade le bureau pour effectuer les modalités de
sortie

Veiller à ce que le malade emporte tous ses effets et ne pas, par erreur, des objets appartenant au
service

Si nécessaire l'aider à faire ses
bagages

Lui donner des conseils nécessaires pour conserver sa santé et des indications pour ses
médicaments, son régime

...

L'agent de santé est tenu au secret professionnel sur tout ce qu'il (elle) apprend au sujet du malade
et de sa famille.

Diapositive 14

Qualités

humaines

Certaines vont de soi : politesse, ponctualité, amabilité, tenue et attitude correcte

D'autres vertus sont importantes ; l'écoute active et attentive, la discrétion

Le malade doit se sentir reconnu, ne pas se sentir comme un étranger, un inopportun

Lancer

alors une petite phrase de reconnaissance qui l'aidera à se sentir à l'aise et à attendre

Diapositive 15

Conditions

matérielles d'un bon accueil

L'apparence du service a un effet sur le patient. Il émanera quelque chose de sympathique et attrayant d'un établissement hospitalier où on aura planté des haies, des parterres de fleurs et dont les murs auront été repeints, crépis ou chaulés.

La propreté et l'hygiène des lieux. Cela implique que soient installés un ou plusieurs bidons recouverts servant de poubelles, placés ni trop près ni trop loin des salles d'hospitalisation, à des endroits évitant des nuisances et le contenu vidé et détruit

.

Le confort du malade sera périodiquement réévalué

.

La discrétion doit être assurée

.

La perturbation sonore doit être réduite au maximum, puisque le matin entre huit heures et midi, une foule de gens qui attendent, discutent et s'énervent à cause des resquilleurs

.

Diapositive 16

CONCLUSION

L'accueil des malades n'est pas que politesse ou gentillesse, mais en grande partie, écouter et organiser l'attente, le confort de ceux qui patientent et la discrétion des consultations.

Un accueil agréable fera beaucoup pour la qualité et la réputation du centre médical. Certes, toutes les propositions précédentes ne sont pas des recommandations, mais nous souhaitons que ce cours sensibilise à la notion d'accueil et surtout vous invite à réfléchir à votre propre accueil dans votre lieu de travail. Car l'entrée d'un malade à l'hôpital est, un univers nouveau pour lui.

Par conséquent aucun domaine ne doit être négligé afin de lui permettre de s'insérer sans avoir « le mal d'hospitalisation ».

Il répond aux besoins d'apprendre et d'éviter le danger selon Virginia Henderson

Diapositive 17

VISITES AUX MALADES

I- DEFINITION

La visite à une personne malade est une action qui consiste à aller voir celle-ci par civilité ou par devoir

.

II- BUT

Réconforter et soutenir celui qui est souffrant

Diapositive 18

III-

ATTITUDES A ADOPTER AU COURS D'UNE VISITE A UN MALADE :

Celui qui vient auprès d'un malade ne doit pas adopter une attitude qui pourrait le nuire ou lui occasionner une gêne quelconque. Au cours de la visite, il ne faut pas aborder des sujets qui pourraient indisposer le malade

Eviter à tout prix les questions, les remarques ou les allusions qui pourraient raviver chez le malade certaines peines ou souffrances

Il est également bien, dans la mesure du possible, de proposer son aide au malade, et lui demander s'il désire quelque

chose

Il faut

dans la mesure du possible, adopter une attitude réconfortante à l'égard du malade (comme par exemple masser son visage ou l'endroit du corps qui le fait souffrir)

,
mais lui tenir des propos encourageants sur son état

Diapositive 19

IV-

CARACTERISTIQUES

D'UNE

VISITE

La

visite doit être relativement brève. En effet, la présence prolongée de quelqu'un à ses côtés peut incommoder plus ou moins fortement le malade, suivant son état. Par ailleurs, ce dernier préfère souvent que ce soit ceux qui sont les plus proches de lui (enfants, parents, amis intimes, époux ou épouse....) qui restent à ses côtés. Néanmoins, si le malade exprime lui-même le désir que la personne qui vient le voir reste plus longtemps, dans ce cas, il n'y a aucun problème.

Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services et la visite doit se faire à une heure appropriée

.

Diapositive 20

V-EFFETS DES VISITES SUR LES MALADES

Sur celui qui reçoit

La visite à un malade peut être une distraction non seulement agréable mais aussi salutaire.

A

l'opposé, il est des visiteurs dont la venue est mal

accueillie

ou dont la personne quoique agréable finit par nuire au malade

Diapositive 21

Sur les autres malades

La gêne provoquée par le son des voix, le bruit, les allées et venues, le grand nombre de visiteurs, la poussière soulevée, intensifient la souffrance des autres malades.

Dispositions à adopter

Connaitre ses malades

Contrôler les visites

Assurer le contrôle du respect des textes

Diapositive 22

CHAMBRE DU MALADE

INTRODUCTION

La chambre du malade, individuelle ou commune est le lieu où le malade, abandonnant son cadre habituel, va passer un séjour plus ou moins long.

Ainsi

, nous aurons une chambre d'accès facile permettant une surveillance régulière pour les cas graves et une chambre agréable, calme et ensoleillée pour les cas chroniques.

L'infirmier

ou la

sage-femme

devra donc préparer la chambre en vue de réserver un agréable accueil au malade

Diapositive 23

I.DESCRPTION

En général, la chambre devra être spacieuse, confortable, agréable, aérée, gaie, bien éclairée, ordonnée et propre.

Dans

les hôpitaux, elle est conçue pour 1 ,2,3 voire 5 lits.

Dès

lors une chambre qui répond aux normes est un allié dans la prestation des soins de qualité.

Elle

doit être un formidable outil pour contrer la propagation des germes dans un hôpital.

Elle

doit être adaptée aux réalités du personnel et faciliter la mise en place de saines habitudes

Diapositive 24

1.1

. La salle d'eau ou box sanitaire

Elle doit renfermée :

- un lavabo en porcelaine
- un bidet
- une cuvette de WC
- un vidoir
- une douche
- un miroir
- un porte savon
- une porte serviette
- un éclairage parfait

Diapositive 25

1.2. Les murs

: Ils doivent être recouverts de carreaux ou de peinture lavable de couleur gaie apaisante.

1.3. Le sol

:

Il sera recouvert en matériaux faciles à nettoyer, de préférence carrelé (grands carreaux)

1.4

.

L'aération

: Facteur important de salubrité, l'aération est assurée soit par des vitres en chicanes réalisant une ventilation indirecte et permanente soit par des fenêtres assurant un renouvellement rapide de l'air.

1.5

.

L'éclairage

:

Il est fourni soit par la lumière naturelle des rayons

solaires

apportant la lumière et la chaleur soit par la lumière artificielle des ampoules électriques placées souvent au plafond, à la tête du lit ou au bas

du mur.

Diapositive 26

II

- MOBILIER

.

II

est composé généralement de :

un lit et ses accessoires

une table de chevet (table de nuit placée à côté du lit)

une table de lit

la literie (matelas, coussin, traversin, draps, alèses, couverture, couvre-lit)

une chaise

un fauteuil

une

armoire

A ce mobilier peut s'ajouter parfois des appareils électroménagers quand il s'agit de chambre individuelle :

-un

réfrigérateur

-un ventilateur

-un poste

téléviseur

Diapositive 27

III - MATERIEL USUEL

Le matériel est spécifique à chaque service mais il s'agit en général de :

- une potence
- un urinal
- un bassin de lit•
- un crachoir
- un bocal

Diapositive 28

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 29

IV-

ENTRETIEN DE LA CHAMBRE

L'entretien de la chambre est fait chaque matin par les filles de salle et les techniciens de surface.

Les

murs et les vitres seront lavés à l'eau savonneuse tous les quinze jours ou au moins une fois par mois

.

- Le

sol sera nettoyé avec une serpillère imbibée d'eau savonneuse tous les matins

- Le

box sanitaire sera désinfecté à

l'eau

javellisée au moins deux fois par

semaine

-

Les tables seront nettoyées après chaque repas. Les bassins, les crachoirs, les boccas seront vidés et lavés après leur utilisation. Ils seront désinfectés une fois par semaine.

- Les

potences, les chaises

et

les lits seront nettoyés une fois par

semaine

Diapositive 30

CONCLUSION

La chambre du malade est sa nouvelle demeure qui lui est imposée à cause de son état pathologique.

Le confort de la chambre contribue à la guérison du malade; il est donc important que celle-ci soit nettoyée régulièrement, rangée.

L'infirmier

doit veiller à ce que tout soit fait selon les règles d'hygiène afin de satisfaire le besoin de sécurité du malade.

Diapositive 31

REPOS

DU

MALADE

INTRODUCTION

On ne peut parler de repos sans songer au sommeil. C'est le sommeil qui procure le grand repos. Il est réparateur et donne la force. Les heures de repos varient selon les individus, la condition de vie et de

climat

I.DEFINITION

:

Dans le domaine infirmier, le repos fait partie des besoins fondamentaux de l'homme

Le

malade a besoin d'autant de repos que de médicaments pour retrouver les forces et santé

Diapositive 32

I

I

. FACTEURS FAVORISANT

LE REPOS

Confort de la pièce

La tension ambiante doit être agréable

La pièce doit être propre, aérée et sans désordre

Le degré de luminosité convenable

Lit avec un matelas confortable

Absence de bruit

Absence de souci majeur

Diapositive 33

III

.

CONDITION D'UN BON DE REPOS

Organisation du service

Respecter et faire respecter les heures de visites

Veiller à ce que le personnel soit discipliné

Ne pas faire de bruit (

conversation

bruyante, grand nettoyage aux heures indues, manipulation de matériel

)

Eduquer les malades et leur famille pour le respect des autres

Eviter de discuter à haute voix, de trainer les pas en marchant

Les services d'intendance seront situés en

fonction

des services d'hospitalisation de manière à ne pas perturber les malades au moment du repos

.

Diapositive 34

Organisation des soins

Suivre autant que possible les habitudes du malade

Ne pas le réveiller, ni l'appeler

à

n'importe quelle heure

Eviter les allées et venues auprès du malade (au lit)

Essayer de créer une ambiance agréable autour du malade

Veiller au confort : réfection du lit tous les jours avec soins d'hygiène

.

Diapositive 35

Education du malade

et/ou

de ses parents

Amener le malade à éduquer ses parents par

rapport

aux

proprétés

des lieux, des locaux et au repos des

autres malades

Discipliner les parents du malade à respecter le régime alimentaire, le repos et le traitement prescrit.

Diapositive 36

REFECTION DU LIT DU MALADE

INTRODUCTION

Le

lit

de façon générale est préparé pour que l'on puisse s'y étendre et y dormir. Mais à l'hôpital, le lit permet au malade de se reposer, de faire sa surveillance et son traitement.

A

cet effet il doit être tenu avec art pour le bien être du malade.

Le lit doit être fait tous les jours, après la toilette, chaque fois que le besoin se fait sentir

Diapositive 37

I- DEFINITION

La réfection de lit occupé consiste à changer le linge sale du lit du malade impotent (qui ne peut pas bouger) par du linge propre.

La réfection de lit non occupé consiste à mettre un linge propre en vue d'installer un malade.

Diapositive 38

II- BUTS

Procurer un confort au malade hospitalisé

Assurer la sécurité du malade (propreté du lit, environnement)

Maintenir une hygiène quotidienne

Prévenir les escarres

Favoriser le confort et la sécurité du malade

Permettre au personnel infirmier de faire tous les autres soins dans un environnement agréable

.

Diapositive 39

III- INDICATION

Tout malade hospitalisé, en particulier les malades
inconscients

IV- LES

DIFFERENTS LITS

Ce sont des lits à particularités : roulette à freins, matelas ferme et plastifié, articulé ou médicalisé
(tête, pied), à hauteur réglable, à barrières,

potence

lit

à retournement (blessés à la colonne

vertébrale)

lit

spécial en fonction de la pathologie (à fluidité pour les grands brûlés).

Diapositive 40

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 41

Un lit d'hôpital

-

Le lit basculant

(même rôle que le lit articulé)

-

Le lit mécanique Dupont

: permet de soutenir plus facilement le malade immobilisé
lorsqu'il

s'agit de lui administrer des soins ou faire sa toilette

-

Le lit Guatheron :

permet de tourner et de maintenir le malade sur le côté grâce au poignet fixé au lit.

-

Le lit à inclinaison latéral :

permet de modifier la position du malade sans le bouger

Diapositive 42

Les accessoires du lit

Ils sont nombreux et assurent la sécurité et le confort du malade et facilitent l'exécution des soins.

Ce

sont :

la

potence

les cales

butoir

les grilles de sécurité (lit d'enfants)

les galeries de

côtés

les porte-bassins, portes

urinal

- les

sonnettes,

etc.

Diapositive 43

Les matelas

Ils peuvent être en crin, en laine, pneumatique ou en mousse de latex.

En

général, le matelas du lit du malade ne doit être ni trop rigide ni trop souple.

Il

est recouvert d'un outil solide et doit être enveloppé d'une housse imperméable

Diapositive 44

I-REFECTION DE LIT NON OCCUPE

3-1-Matériel

-

2 draps propres

(un drap de dessus, un drap de dessous)

-

1 couverture

-

1 couvre-lit

-

2 alèzes

(coton, toile cirée)

- des

oreillers

-

1

chariot ou 2

chaises

3-2-Technique (

voir

TP)

Diapositive 45

IV- REFECTION DE LIT OCCUPE

4-1-Préparation du

soin

Aller

évaluer le degré d'autonomie du patient

S'il est conscient lui expliquer le soin

Rassurer le patient pour dissiper sa
crainte

4-2- Matériel

- 2

draps propres

- 1 couverture

- 1 couvre-lit

- 2 alèzes

(coton, toile cirée)

- 1chariot

ou deux(2) chaises

-

1sac

à linge

4-3-Technique (voir TP

)

Diapositive 46

CONCLUSION

La réfection de lit est un acte de soin qui assure au malade un mieux-être

.

Elle

contribue à la qualité de la prestation des services et valorise l'intervention infirmière dans la statistique des besoins de dépendance du client.

Diapositive 47

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 48

BROU FELIX, INSPECTEUR DES SOINS INFIRMIERS
DOCTORANT EN SCIENCES DE L'EDUCATION
COORDONNATEUR DES STAGES

Diapositive 49

LE THERMOMETRE MEDICAL

DEFINITION

Le thermomètre médical est un appareil qui sert à mesurer et à afficher la valeur de la température du corps humain

L'unité de mesure de la température est le degré Celsius
(°C)

Diapositive 50

II. LES DIFFERENTS MODELES DE THERMOMETRE

Il y a plusieurs types de thermomètre qui sont :

le

thermomètre au gallium ou au

galinstan

(= médical)

le

thermomètre à mercure (

proscrit

)

le

thermomètre à

carbone

le

thermomètre

électronique:

- le

thermomètre

frontal

- le

thermomètre à infra

rouge

- le

thermomètre

auriculaire

- le

thermomètre

buccal

- le

thermomètre

sucette

- le

thermomètre digital.

Cependant nous allons décrire ceux qui sont utilisés dans nos services

Diapositive 51

2-1 Le thermomètre médical

C'est le thermomètre au gallium qui est communément appelé le thermomètre médical. Il se compose d'un tube de verre fermé, fixé à une règle graduée allant de 35°C à 42°C et d'une extrémité renflée (cuvette) contenant du mercure. À l'intérieur se trouve un tube très fin dans lequel le mercure remonte quand il est chauffé

Diapositive 52

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 53

2-2 Le thermomètre électronique

C'est un appareil qui fonctionne selon un système électrique et comporte sur une de ses faces un tableau d'affichage

automatique, la

valeur de la température.

Un

signal sonore

annonce

l'affichage de la température

Diapositive 54

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 55

III LES VARIATIONS DE LA TEMPERATURE

L'équilibre entre la production et la perte de température par l'organisme s'appelle
la

thermorégulation

Elle

se fait naturellement mais il peut arriver que des éléments perturbent cet équilibre provoquant ainsi
une production excessive de chaleur par l'organisme ou un refroidissement de celui-ci.

Cette

variation de température peut être physiologique ou pathologique

Diapositive 56

3-1

Les variations physiologiques

Elles dépendent de nombreux facteurs :

le climat

l'heure (4h-8h T° basse, 16h - 18h T° élevée)

la digestion (repas abondant T° élevée, diète T° basse)

le travail physique et intellectuel

les émotions, le repos

l'âge (nouveau né température irrégulière, vieillard température en dessous de la normale)

Diapositive 57

3-2 Les variations pathologiques

Elles sont de deux natures :

l'hyperthermie ou l'

hyperpyrexie

=

élévation de la température au dessus de

37,5°C.

C'est le cas dans le paludisme ;

- l'hypothermie ou l'

hypopyrexie

= baisse de la température en dessous de 36°C. C'est le cas dans le choléra

Diapositive 58

IV

LES DIFFERENTS SITES DE PRISE DE LA TEMPERATURE

Dans les cavités

naturelles:

le rectum

le vagin

la bouche

l'oreille

La température ainsi obtenue est dite température des cavités naturelles

Diapositive 59

En

surface du corps:

le front

le creux axillaire

la région sous mammaire

la région inguinale

Le pli du coude

le creux du genou

La température ainsi obtenue est dite température des surfaces cutanées

Diapositive 60

V- LES TECHNIQUES DE PRISE DE TEMPERATURE

5-1

La température

axillaire

(1/2)

Si

c'est un thermomètre médical à mercure, faire descendre le mercure dans la cuvette en le secouant ;

Si

c'est un thermomètre

électronique

le

mettre

à

zéro

t

amponner

l'aisselle avec du coton ou une compresse pour enlever la sueur,

installer le malade (coucher sur le dos ou sur le côté),

placer la cuvette du thermomètre au creux de l'aisselle et serrer le bras sur le thermomètre contre le thorax

Diapositive 61

(2/2

)

-

retirer

le thermomètre au bout de 5 à 10

minutes

lire la température en inclinant de profil le

thermomètre

Ajouter 5/10

ème

de degré pour obtenir la température des cavités

naturelles

noter avec

un stylo bleu

la température sur la feuille de température ou la feuille de
surveillance

Diapositive 62

Contre-indications

:

personnes maigres

nouveau-nés

enfants

Diapositive 63

5-

2 La température
rectale

(
1/2
)

S'

assurer

qu'il n'a pas envie d'aller à la selle en ce
moment

installer le malade sur le côté, la cuisse supérieure légèrement repliée sur
l'abdomen

Si

c'est le thermomètre médical faire descendre le mercure dans la cuvette en le secouant, si c'est un
thermomètre électronique le mettre à

zéro

lubrifier légèrement le
thermomètre

Diapositive 64

(2/2)

introduire

le thermomètre dans l'anus et le pousser doucement dans le rectum

jusqu'à 4 cm

environ ;

si

le malade sait le placer laisser le faire sous votre surveillance,

laisser le thermomètre en place pendant 3 minutes,

essuyer le tube de verre s'il est sale avec du coton imbibé d'eau savonneuse ou un antiseptique (dakin),

lire la température en inclinant de profil le thermomètre,

noter avec

un stylo bleu

la température sur la feuille de température ou la feuille de surveillance

Diapositive 65

Contre-indications

Abcès de la région anale

Infection intestinale

Etranglement hémorroïdaire

Intervention sur le rectum

Diapositive 66

La température buccale

Thermomètre

sucette

(

1/2

)

Surtout avec le thermomètre électronique à cause des accidents qui peuvent survenir avec le mercure.

Il

ne doit pas se prendre immédiatement après le repas ou après la prise d'une boisson chaude ou froide

le malade peut rester assis ou couché

mettre le thermomètre à zéro

Diapositive 67

(2/2)

placer

l'extrémité du thermomètre sous la langue

le malade doit s'abstenir de parler

laisser le thermomètre en place pendant 3 minutes

le retirer dès le signal sonore

lire la température affichée et la notée avec un

stylo bleu

sur la feuille de température ou la feuille de surveillance

Diapositive 68

Contre indications

:

Malade délirant

Enfant malade atteint de rhinite

NB :

noter avec un

stylo bleu

la température

sur la feuille de température ou la feuille de surveillance,

nettoyer méticuleusement le thermomètre avec du coton et de l'eau savonneuse ou un antiseptique
le sécher et le ranger

Diapositive 69

Le thermomètre médical doit être individuel pour éviter les contaminations.

Privilégier toujours la voie rectale s'il n'y a pas de contre indications à cette voie.

Faire toujours la communication pour le changement de comportement (C.C.C.) et le remercier avant de prendre congé de lui

.

Diapositive 70

CONCLUSION

La température est un élément déterminant du diagnostic donc sa prise doit faire l'objet d'une attention particulière. C'est pourquoi, il est important de savoir utiliser le thermomètre et de connaître les différentes techniques de prise de la température

.

Diapositive 71

LA TEMPERATURE

INTRODUCTION

La température est une grandeur physique qui mesure le degré de chaleur d'un corps ou d'un milieu

Lorsque deux corps sont placés dans une enceinte adiabatique, le corps le plus chaud cède de la chaleur au corps le plus froid, jusqu'à ce que les deux corps aient la même température (équilibre thermique)

La température se mesure à l'aide d'un thermomètre

Diapositive 72

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 73

I. DEFINITION

La température du corps humain est le degré de chaleur stocké par l'organisme

Elle est soit :

physiologique:

normale

pathologique:

due à la maladie

La température se mesure à l'aide d'un thermomètre médical et s'exprime en degré Celsius (°C)

La température normale au repos se situe entre 36,5°C et 37 °C le matin et entre 37°C et 37°5 le soir

Diapositive 74

2. Les

variations pathologiques

L'hyperthermie :

C'est l'élévation de la température du corps au-dessus de 37,5°C

L'Hypothermie :

baisse de la température du corps au dessous de 36,5°C

Diapositive 75

III)

RÔLE

DE

L'AGENT DE SANTE

Hyperthermie

Prendre la température et la noter

Déshabiller

le malade

Faire un enveloppement humide

Lui donner à boire fréquemment

Faire un bain avec de l'eau de réseau (ou à – 2°C de la température mesurée)

Diapositive 76

2- Hypothermie

Prendre régulièrement la température et noter

Habiller chaudement le client et le couvrir

Mettre une bouillotte auprès du client

Diapositive 77

LES METHODES DE CORRECTION THERMIQUE

INTRODUCTION

Elles visent à corriger les hypo et hyperthermies afin d'en limiter les complications.

Les soins de correction des hypothermies visent à réchauffer progressivement et en toute sécurité la personne soignée.

Les soins de correction de l'hyperthermie visent à refroidir la personne progressivement en toute sécurité.

Dans ce cours nous ne parlerons que de la bouillotte qui sera utilisée pour réchauffer et de la vessie de glace pour refroidir

Diapositive 78

A) LA BOUILLOTE

DEFINITION

Une bouillotte est un

réceptif

étanche servant à contenir de l'

eau

chaude, généralement utilisé pour tenir une personne au chaud, notamment lorsque celle-ci est dans son

lit

ou malade. Elle peut être utilisée simplement pour réchauffer le lit avant de se coucher. Les bouillottes sont généralement faites en

caoutchouc

.

Diapositive 79

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 80

TECHNIQUE

Remplir à moitié la bouillotte avec de l'eau à 80°C chez l'adulte.

Chasser l'air avant de fermer en appuyant sur la poche.

Fermer et vérifier l'étanchéité.

Envelopper la bouillotte d'un morceau de tissu.

Disposer la bouillotte soit à dix centimètres des pieds de la personne soit sur une partie précise du corps de la personne.

Après usage égoutter la bouillotte, la laisser sécher et désinfecter si nécessaire

Diapositive 81

II- ELEMENTS
DE SURVEILLANCE

La

peau du malade

La température

du malade

Diapositive 82

B- VESSIE DE GLACE

INTRODUCTION

C'est une poche en caoutchouc, où l'on introduit des glaçons

La thérapie par le froid consiste à appliquer le froid pour soulager un

pat

ient

Diapositive 83

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 84

I-

INDICATIONS

Médicales

:

(1/2)

Hémorragies

Méningites

Soulager

une

douleur

Diminuer

une

enflure

Fièvre

Diapositive 85

Chirurgicales

(2/2

)

Limiter un épanchement de sang dans les tissus

Appendicites

Salpingites aiguës

Fracture du crâne

Péritonite

Diapositive 86

II- MATERIEL

Vessie de glace

Glaçon ou glace pilée

Talc

Alaise ou linge de dimension adaptée à la région à traiter ou une serviette

Diapositive 87

III-

TECHNIQUE

Remplir la poche ou la vessie aux 2/3 avec des glaçons ou de la glace pilée

Entourer

la poche avec un linge

Talquer la surface cutanée à traiter et y placer la poche

Maintenir la poche en place avec une bande souple et élastique renouveler aussi souvent que nécessaire selon la prescription médicale

N.B

: ne jamais appliquer la vessie de glace au niveau du cœur

Diapositive 88

IV-

ELEMENTS DE SURVEILLANCE

La température du malade

Recherche d'une diminution, d'une absence ou d'une augmentation de la douleur

Diapositive 89

LE POULS

INTRODUCTION

L'appréciation des pulsations se réalise par la pression des doigts sur le trajet ou au moyen d'un appareil de mesure électronique

La mesure des pulsations permet d'apprécier le rythme, la fréquence, l'amplitude, le caractère des battements cardiaques

Elle fait partie du recueil des informations qui concourent à la connaissance et à la surveillance de l'état de santé d'une personne

Diapositive 90

DEFINITION

Le pouls est la sensation de soulèvement perçue par le doigt qui déprime une artère superficielle sur un plan osseux

Diapositive 91

II- OBJECTIFS

Surveiller l'état de santé d'une personne

Apprécier la fréquence et le rythme cardiaque

Déceler des anomalies du fonctionnement de l'appareil cardio-vasculaire

Evaluer la régularité et la force du pouls

Apprécier les effets d'un traitement médicamenteux

Diapositive 92

III- MATERIEL

Un stylo rouge

Une feuille de température ou un carnet de santé

Une montre à trotteuse (ou appareil de mesure électronique)

Diapositive 93

IV-

DIFFERENTS SITES DE PRISE DU

POULS (1/2)

Les pulsations peuvent être perçues à différents niveaux :

MEMBRES SUPERIEURS :

Au niveau de l'artère radiale (pouls radial)

FACE ET COU

Artère temporale

Carotide externe (devant l'oreille)

Carotide interne (en avant du cou)

Diapositive 94

(2/2

)

MEMBRES

INFERIEURS

Artère fémorale (pli de l'aîne)

Artère poplitée (sous le genou)

Artère pédieuse (au dessus pied)

Diapositive 95

Les sites de prise du pouls

Diapositive 96

V-

VARIATIONS DES PULSATIONS

Elles sont de deux ordres :

physiologique

pathologique

Diapositive 97

Variations physiologiques

Elles varient suivant certains

facteurs:

- l'âge
- l'émotion
- l'effort

Diapositive 98

L'âge	
Fœtus	
.....	140 à 160
pulsations/mn	
A la naissance.....	130 à 140
A 4 mois	130
A 1 an.....	100 à 130
A 5 ans	
.....	100
A 14 ans	
.....	81
à 85	
Adulte	
.....	60
à 80	
Vieillard	
.....	60
à 70	

Diapositive 99

L'émotion

Toute émotion provoque une accélération du rythme

L'effort

Accélération du rythme correspondant à l'accélération des contractions cardiaques

Diapositive 100

2-Variations pathologiques

Elles varient selon l'état du cœur et sont en rapport avec la rapidité, la régularité et l'amplitude cardiaque

la tachycardie : fréquence accélérée au-dessus de

100 pulsations/mn

chez l'adulte

Cela se voit en présence d'une émotion, d'un effort, de la prise de café

la bradycardie : fréquence ralentie au-dessous de 60 pulsations par minute chez l'adulte

Diapositive 101

VI- TECHNIQUE

Lavage simple des mains

Expliquer le soin au client

Choisir le site

Palper le pouls

Appuyer avec l'index et le majeur

Compter pendant 1 minute

Noter le soin avec un

stylo rouge

sur la feuille de température

Diapositive 102

LA TENSION ARTERIELLE

INTRODUCTION

La mesure de la tension artérielle est un acte de soin qui consiste à apprécier la pression selon laquelle le sang circule dans les artères

L'appréciation de la pression artérielle fait partie des informations qui concourent à la connaissance et à la surveillance de l'état de santé d'une personne

La mesure de la pression artérielle se fait au moyen d'un tensiomètre

Il s'agit de mesurer la pression artérielle en position couchée bras le long du corps. En position assise au niveau de l'artère brachiale

Diapositive 103

DEFINITION

La tension artérielle est la pression sous laquelle le sang circule dans les vaisseaux.

Elle dépend surtout de :

la force de contraction du cœur

l'état des vaisseaux

la masse sanguine

Diapositive 104

II- OBJECTIFS

surveiller la santé d'une personne

identifier les signes d'aggravation subite de l'état du patient (choc)

surveiller un patient en période postopératoire

surveiller les chiffres de pression artérielle

comparer les résultats en fonction des positions debout/couché

apprécier les effets d'un traitement antihypertenseur

Diapositive 105

III-MATERIEL

La mesure se fait à l'aide d'un appareil appelé tensiomètre

. Il est composé de :

un manomètre gradué de 1 à 30 cm Hg ou de 0 à 300 mm hg

un brassard pneumatique

une poire servant à gonfler le brassard

un stéthoscope

-

un stylo rouge

Il existe des tensiomètres électroniques

Diapositive 106

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 107

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 108

IV- TECHNIQUE

Expliquer au
patient

le soin, le rassurer

Mettre le
patient

au repos pendant au moins 15 min dans une chambre calme en position couchée

Envelopper correctement le bras à l'aide du brassard de dimension appropriée, la poche gonflable sur le trajet de l'artère humérale, le bord inférieur de 2 à 3 cm du pli du coude.

Le cadran du manomètre doit être visible

Palper le pouls de l'artère humérale

Diapositive 109

- Placer

les écouteurs du stéthoscope dans les oreilles et poser la capsule du stéthoscope au-dessus de l'artère humérale.

Fermer la vis de la poire

Gonfler le brassard doucement jusqu'à la disparition du pouls radial

Dégonfler progressivement tout en regardant l'aiguille du manomètre revenir.

Le chiffre indiqué par l'aiguille lorsqu'on entend le bruit qui devient régulier correspond à la maxima (ou tension systolique, cela est en rapport avec la contraction du ventricule

)

Continuer à dégonfler le brassard ; le chiffre indiqué par l'aiguille lorsque les battements cessent représente la minima (tension diastolique, cela traduit la résistance des vaisseaux au moment de la diastole ventriculaire

)

Diapositive 110

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 111

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 112

V- VARIATIONS

Variation physiologique

L'âge :

nouveau-né : 6/3

cmHg

adulte

: 12/7cmHg

vieillard

: 16/9 cmHg

L'émotion et l'effort physique

L'heure

: elle est plus basse le matin et pendant le sommeil ; elle s'élève pendant les activités

Les positions corporelles

: elle est plus basse en position

couchée

Diapositive 113

2-Variation pathologique

hypertension artérielle

hypotension artérielle

Diapositive 114

LA MESURE DE LA FREQUENCE RESPIRATOIRE

INTRODUCTION

La respiration est un phénomène biologique automatique et reflexe, commandée par le centre bulbaire

La respiration est un processus de ventilation qui assure les échanges gazeux entre l'organisme et son environnement.

Elle permet d'absorber de l'oxygène et d'éliminer du gaz carbonique produit du métabolisme.

Elle est constituée par l'inspiration et l'expiration

Diapositive 115

1-

DEFINITION

Elle consiste à mesurer le nombre de mouvements respiratoires pendant une minute

2. But

Evaluer la fonction respiratoire

3. Indications

Evaluation de la fonction respiratoire lors d'une pathologie ou d'un traitement

Surveillance du patient (lors d'une transfusion sanguine)

Diapositive 116

4- Matériel

Montre à trotteuse centrale

Feuille de température ou carnet de santé

Désinfectant pour les mains

Stylo vert

Diapositive 117

5- Technique

Préparation du soin

Ne pas informer le
patient

du soin consistant à mesurer sa respiration afin de ne pas perturber les résultats par une concentration du patient sur les mouvements respiratoires

Dire au
patient

par exemple que vous venez mesurer le pouls

S'installer face au client et observer la respiration au repos

La mesure de la respiration est plus fiable quand elle est faite durant le sommeil chez l'enfant et à la suite de la prise du pouls chez l'adulte

Diapositive 118

Mesure de la fréquence respiratoire

Se désinfecter les mains

Observer les mouvements respiratoires du thorax et compter la respiration pendant une (01)

minute

Chez l'adulte on peut poser la main sur le thorax et compter pendant

1

minute

Chez l'enfant compter les mouvements respiratoires au niveau abdominal

Noter le soin

Diapositive 119

6

. Les variations de la respiration

6-1

Les variations physiologiques

La volonté :

la personne peut volontairement accélérer ou ralentir momentanément le rythme respiratoire de son organisme

La température ambiante :

la chaleur augmente le rythme respiratoire

Le rythme journalier :

le sommeil, le repos ralentissent le rythme respiratoire.

Les

stress, peurs, émotions, travail musculaire en accélèrent le rythme.

L'âge

: le rythme est plus accéléré chez l'enfant

La position corporelle

: la respiration corporelle s'accélère en position debout

Diapositive 120

6-2

Les variations pathologiques

La dyspnée

: difficulté respiratoire soit d'effort, de décubitus ou une orthopnée (soulagement en position assise ou penchée en avant, permanente)

La bradypnée :

ralentissement du rythme respiratoire

La polypnée :

accélération du rythme respiratoire

L'apnée :

pause plus ou moins prolongée de mouvements respiratoires

le tirage :

dépression inspiratoire de la paroi thoracique de part et d'autres du sternum se produisant lors d'une difficulté d'entrée de l'air dans les voies respiratoires

Respiration stertoreuse

: respiration s'accompagnant d'un ronflement bruyant à l'inspiration/l'expiration

Diapositive 121

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 122

C - TRAITEMENT PARENTERAL

LES

INJECTIONS PARENTERALES

DEFINITION

Une

injection parentérale est un soin sur prescription médicale qui consiste à introduire dans l'organisme des substances médicamenteuses par une autre voie que le tube digestif (per os) au moyen d'une seringue et d'une aiguille.

Il existe différents types d'injections :

intradermique

sous-cutanée

- intramusculaire

- intraveineuse

BUT

-

Obtenir une action plus précise et plus rapide.

NB :

les médicaments passent plus rapidement dans la circulation sanguine.

la dose injectée est parfaitement connue.

Diapositive 123

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 124

INJECTION INTRADERMIQUE

Diapositive 125

DEFINITION

C'est

l'introduction de toute petite quantité de produit médicamenteux dans le derme.

Zones

de ponction

:

Face interne et externe de l'avant bras

Face

externe du

bras

Face

externe de la

cuisse

Au

niveau de toute région douloureuse lorsqu'il s'agit de thérapeutique analgésique.

MATERIEL

Plateau stérile

Plateau

propre

Produit médicamenteux

Seringue à insuline stérile

Alcool

Coton hydrophile

Gant propre

Diapositive 126

TECHNIQUE DE L'INJECTION INTRADERMIQUE

Désinfecter la zone de ponction en

"escargot" :

mouvement circulaire en partant du centre vers l'extérieur afin de tuer et d'éloigner les germes du point de ponction.

Aseptiser la zone de ponction à l'alcool.

Tenir le bras à pleine main et bien tendre la peau.

De l'autre main saisir la seringue

,

et introduire la pointe de l'aiguille dans le derme, le biseau vers le haut pour éviter au liquide de se répandre en profondeur.

Dès que le biseau a disparu, pousser doucement l'aiguille et injecter le volume d'une lentille

L'injection doit produire immédiatement une papule (une petite boule d'œdème blanc ou peau d'orange).

Si la papule ne se forme pas, l'injection doit être recommencée dans un autre endroit.

Après le retrait de l'aiguille, éviter d'essuyer ou d'appuyer au point d'injection.

Réinstaller le malade.

Noter le soin.

Ranger le matériel.

Diapositive 127

INJECTION SOUS CUTANEE (S/C)

I- DEFINITION

L'injection sous-cutanée (S/C) est l'administration d'un produit médicamenteux présenté sous forme injectable dans le tissu cellulaire sous-cutané

.

Zones

de ponction :

Face externe du

bras

Face

externe de la cuisse ou face

antérieure

Zone

externe de

l'abdomen

Omostrate

.

II- INDICATION

Absorption lente : le tissu sous-cutané est moins vascularisé que le tissu musculaire.

Diapositive 128

III-

MATERIEL

Plateau stérile

Produit

à injecter.

Matériel pour la préparation du produit.

Seringue stérile 1 ml à 20 ml en fonction de la quantité du produit à injecter ou seringue à insuline ou dispositif prêts à l'emploi.

Aiguille sous-cutanée (orange : 25 Gauge, marron : 26 Gauge).

Compresse non stériles ou boules de coton.

Antiseptique ou alcool modifié à 70°.

Pansement ou compresse et sparadrap.

Gants non stériles à usage unique.

Réniforme (haricot).

Sac à élimination des déchets.

Conteneur à déchets contaminés piquants et tranchants.

Désinfectant de surface et

chiffonnette

.

Nécessaire à l'hygiène des mains

Diapositive 129

Les aiguilles

Couleur

Gauge

Diamètre

Utilisation

Jaune

30 Gauges

0,30 mm

Injection SC / intradermique

Gris

27 Gauges

0,40 mm

Injection SC

Brun

26 Gauges

0,45 mm

Injection SC

Orange

25 Gauges

0,50 mm

Injection SC

Bleu

23 Gauges

0,60 mm

Injection SC / IV / IM - Prélèvement IV

Diapositive 130

IV-

REALISATION DU

SOIN (1/3)

Vérifier la prescription médicale.

Préparer le produit à injecter.

Prévenir le patient du soin.

Effectuer un lavage simple des mains ou un traitement hygiénique.

Installer le matériel après vérification des dates de péremptions et de l'intégrité des emballages.

Installation sur une surface propre et désinfectée au préalable.

Installer le rétiniforme et le container à déchets contaminés piquants loin du matériel propre.

Installer confortablement le patient en ne découvrant que la zone de ponction.

Effectuer un lavage simple des mains ou un traitement hygiénique.

Mettre les gants non stériles.

Désinfecter la zone de ponction en

"escargot" :

mouvement circulaire en partant du centre vers l'extérieur afin de tuer et d'éloigner les germes du point de

ponction

Diapositive 131

IV-

REALISATION DU SOIN (2/3)

Faire un pli cutané entre le pouce et l'index.

Introduire l'aiguille avec un angle de 45° ou 90° selon l'épaisseur du tissu cutané, d'un geste rapide, précis et ferme.

Ne

pas relâcher la peau car le relâchement des tissus risquerait d'introduire l'aiguille dans un muscle.

Tirer le piston pour vérifier l'absence d'un reflux sanguin. S'il y a un reflux sanguin, sortir l'aiguille et préparer une nouvelle seringue.

Lors d'injection d'insuline ou d'héparine, il n'est pas nécessaire de rechercher un reflux sanguin puisqu'un passage faible de ces produits dans la circulation sanguine est sans conséquence.

Injecter lentement le produit.

Retirer l'aiguille d'un geste rapide et recouvrir le point de ponction d'une compresse imbibée d'antiseptique

Diapositive 132

IV-

REALISATION DU SOIN

(3/3)

Jeter

immédiatement la seringue et l'aiguille dans le container à déchets contaminés piquants.

Ne pas masser le point de ponction pour ne pas faire sortir le produit injecté par pression.

Jeter les gants.

Eliminer les déchets et désinfecter le matériel utilisé.

Effectuer un lavage simple des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains par frictions avec une solution hydro-alcoolique.

Réinstaller le patient.

Noter le soin

Diapositive 133

V-

COMPLICATIONS

Ecchymose.

Douleur.

Choc anaphylactique : réaction allergique.

Lipodystrophies

dues à des injections répétées au même endroit.

Altération de l'état cutané.

VI- SURVEILLANCE

ET EVALUATION

Surveillance du point de ponction.

Surveillance de l'état cutané.

Surveillance des réactions possibles du patient après l'injection

Diapositive 134

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 135

INJECTION INTRA MUSCULAIRE

I- DEFINITION

L'injection intramusculaire (IM) est l'administration dans un muscle d'un produit médicamenteux présenté sous forme injectable.

Zones

de ponction :

Muscle grand et moyen fessier

: quart

supéro

-externe de la

fesse

Muscle

vaste externe de la cuisse

: s'étend d'une largeur de main au-dessus du genou à une largeur de main au-dessous du grand trochanter du

fémur

Muscle

deltoïde

: juste en dessous de l'épaule si la quantité du produit à injecter ne dépasse pas les 2 ml

.

Diapositive 136

II- INDICATIONS

Nécessité

d'une absorption et donc une action rapide : la résorption est rapide à cause de la vascularisation importante des

muscles

Voie

exclusive d'usage pour certains produits (ex : la pénicilline retard)

Voie

d'urgence dans un centre non

équipé

Diapositive 137

III- MATERIEL

Plateau stérile

Chariot

Produit à injecter.

Seringue stérile 1 ml à 20 ml en fonction de la quantité du produit à injecter.

Aiguille intramusculaire (noir : 22 Gauge ; verte : 21 Gauge).

Compresse non stériles ou boules de coton.

Antiseptique ou alcool modifié à 70°.

Compresse et sparadrap.

Gants propres.

Réniforme (haricot).

Sac à élimination des déchets.

Boîte de sécurité ou Conteneur à déchets contaminés piquants et tranchants.

Désinfectant de surface et

chiffonnette

.

Nécessaire à l'hygiène des mains. (solution hydro alcoolique ou eau, savon et serviette jetable
)

Diapositive 138

IV- TECHNIQUE

DU

SOIN (1/4)

Vérifier la prescription médicale.

Préparer le produit à injecter.

Prévenir le patient du soin.

Effectuer un lavage simple des mains ou un traitement hygiénique.

Réunir le matériel après vérification des dates de péremptions et de l'intégrité des emballages.

Placer le matériel sur une surface propre et désinfectée au préalable.

Installer le réniforme et le container à déchets contaminés piquants loin du matériel propre.

Respecter le triangle d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie : Propre (matériel) - Patient - Sale (poubelles).

Diapositive 139

IV- TECHNIQUE DU SOIN

(2/4)

Installer

confortablement le patient en ne découvrant que la zone de ponction.

Effectuer un lavage antiseptique des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains par frictions avec une solution hydro-alcoolique :

hygiène des mains

.

Mettre les gants non stériles.

Tendre la peau.

Désinfecter la zone de ponction en

"escargot"

: mouvement circulaire en partant du centre vers l'extérieur afin de tuer et d'éloigner les germes du point de ponction.

Demander au patient d'expirer afin de détendre son muscle et diminuer la douleur lors de la piqûre.

Introduire l'aiguille au moment de l'expiration, d'un geste rapide, précis et ferme.

Relâcher la peau.

- Tirer

le piston pour voir si l'aiguille se trouve dans le muscle

Diapositive 140

IV- TECHNIQUE DU SOIN

(3/4)

Tirer

le piston pour voir si l'aiguille se trouve dans le muscle :

S'il y a un reflux sanguin, c'est que l'aiguille est dans un vaisseau, dans ce cas là, sortir un peu l'aiguille sans la retirer entièrement, pencher légèrement l'aiguille pour changer de plan et réintroduire l'aiguille.

Vérifier l'absence de reflux sanguin, en aspirant de nouveau.

Si du sang en plus grande quantité apparaît dans la seringue, retirer l'aiguille ; préparer à nouveau l'injection et piquer dans un autre site

.

Injecter lentement le produit.

Au-delà de 5 ml de produit injecté (2ml s'il s'agit du muscle deltoïde), changer de plan d'injection : sortir un peu l'aiguille sans la retirer entièrement, pencher légèrement l'aiguille ce qui permet de changer le plan et réintroduire l'aiguille.

Si la quantité à injecter est supérieure à la quantité contenue dans la seringue, désadapter la seringue de l'aiguille sans retirer l'aiguille et sans la toucher (prendre une compresse stérile pour éviter les risques de contamination), adapter la nouvelle seringue purgée à l'aiguille, changer de plan, vérifier l'absence de reflux et injecter le produit tout en surveillant les réactions du patient

Diapositive 141

IV- TECHNIQUE DU SOIN

(4/4)

Retirer

l'aiguille d'un geste rapide et recouvrir le point de ponction d'une compresse imbibée d'antiseptique.

Jeter immédiatement la seringue et l'aiguille dans le container à déchets contaminés piquants.

Masser le point de ponction pour diffuser le médicament dans le muscle.

Mettre un pansement.

Jeter les gants.

Éliminer les déchets et désinfecter le matériel utilisé.

Effectuer un lavage simple des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains par frictions avec une solution

hydro-alcoolique

Réinstaller

le patient

Diapositive 142

V- INCIDENTS

ET ACCIDENTS

Hématome

Douleur

Choc

anaphylactique : réaction

allergique

Abcès

post injection

VI-

SURVEILLANCES

ET

EVALUATIONS

Surveillance

du point de ponction. (Hématome,
inflammation)

Surveillance

des réactions possibles du patient pendant l'injection. :

Visage

Transpiration

Respiration

rapide etc.

Diapositive 143

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 144

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 145

INJECTION INTRA VEINEUSE DIRECTE (
IVD)

I- DEFINITION

L'injection intraveineuse directe (IVD) est l'administration directement dans une veine d'un produit médicamenteux présenté sous forme injectable

II- INDICATIONS

Nécessité d'une action
rapide

Médicaments pouvant être caustiques pour les tissus sous-cutanés et musculaires (risque de douleur, œdème, nécrose

)

Diapositive 146

III-

MATERIEL

Produit à injecter.

Matériel pour la préparation du produit.

Seringue stérile 1 ml à 20 ml en fonction de la quantité du produit à injecter.

Aiguille intraveineuse (jaune : 20 Gauge).

Garrot désinfecté.

Compresse non stériles ou boules de coton.

Antiseptique.

Pansement ou compresse et sparadrap.

Gants non stériles à usage unique.

Alèze ou toile cirée

Réniforme (haricot).

Sac à élimination des déchets.

Conteneur à déchets contaminés piquants et tranchants.

Désinfectant de surface et

chiffonnette

.

Nécessaire à l'hygiène des mains (solution hydro alcoolique)

Diapositive 147

Les aiguilles

Couleur

Gauge

Diamètre

Utilisation

Bleu

23 Gauges

0,60 mm

Injection SC / IV / IM - Prélèvement IV

Noir

22 Gauges

0,70 mm

Injection IM / IV - Prélèvement IV

Vert

21 Gauges

0,80 mm

Injection IM / IV - Prélèvement IV

Jaune

20 Gauges

0,90 mm

Prélèvement IV

Crème

19 Gauges

1,10 mm

Prélèvement IV

Diapositive 148

IV-

TECHNIQUE DU

SOIN

(1/2)

Vérifier la prescription médicale.

Préparer en respectant les règles d'hygiène, le produit à injecter.

Effectuer un lavage simple des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains par frictions avec une solution hydro-alcoolique.

Installer le matériel après vérification des dates de péremptions et de l'intégrité des emballages.

Installation sur une surface propre et désinfectée au préalable.

Installer le réniforme et le container à déchets contaminés piquants loin du matériel propre.

Effectuer un lavage simple des mains ou un traitement hygiénique

.

Diapositive 149

IV-

TECHNIQUE DU SOIN

(2/2)

Mettre le garrot et vérifier la présence d'un pouls artériel en contrebas (pouls radial), sinon, risque de thrombose.

Demander au patient de serrer le poing.

Choisir la veine : préférer une veine de gros calibre pour les injections.

Favoriser la vasodilatation de la veine, ce qui rend le geste plus facile

Demander au patient de serrer le poing.

Mettre le bras en déclive.

Diapositive 150

V-

CHOIX DE LA VEINE DU MEMBRE
SUPERIEUR

(1/2)

La veine doit être droite sans courbure loin d'une région osseuse ou du pli

Effectuer un lavage antiseptique des mains ou un traitement hygiénique.

Mettre les gants non stériles.

Mettre la protection sous la zone de ponction.

Effectuer un lavage antiseptique des mains ou un traitement hygiénique.

Mettre les gants propres

Pratiquer une antisepsie de la peau :

Procéder en partant du bas vers le haut afin de favoriser un afflux de sang.

Ne jamais repasser à un même endroit.

Utiliser une compresse par passage puis la jeter dans le sac à
déchets

Introduire

l'aiguille biseau vers le haut, dans la veine, puis abaisser légèrement l'aiguille parallèlement à la
peau et pénétrer la veine sur une distance d'au moins 1 cm

Diapositive 151

V-

CHOIX DE LA VEINE DU MEMBRE SUPERIEUR

(2/2)

Vérifier

le reflux sanguin en tirant légèrement le piston. S'il n'y a pas de reflux sanguin, mobiliser l'aiguille pour l'introduire dans la

veine

Enlever

le garrot, si présence d'un reflux

sanguin

Demander

au patient de desserrer le

poing

Injecter

le produit lentement tout en surveillant la réaction du

patient

Retirer

l'aiguille et comprimer le point de ponction d'une compresse imbibée d'antiseptique

Jeter

immédiatement la seringue et l'aiguille dans le container à déchets contaminés

piquants

Mettre

un

pansement

Jeter

les

gants

Eliminer

les déchets et désinfecter le matériel

utilisé

Effectuer

un lavage simple des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains par frictions avec une solution

hydro-alcoolique

Réinstaller

le patient

.

Diapositive 152

Les sites d'injection intraveineuse du
membre supérieur

(F 1)

Diapositive 153

RISQUES ET COMPLICATIONS

Hématome

Douleur

Choc anaphylactique : réaction

allergique; stopper

l'injection, prévenir le

médecin

VII.

SURVEILLANCES

ET EVALUATIONS

Surveillance du point de ponction.

Surveillance des réactions possibles du patient après l'injection

Diapositive 154

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 155

PRELEVEMENT DE
SANG PAR
PONCTION VEINEUSE
I.DEFINITION

La ponction veineuse est le prélèvement d'un échantillon de sang veineux afin de réaliser une analyse de biologie médicale

II. INDICATIONS

Dépister des troubles
biologiques

Aider au
diagnostic

Suivre l'évolution d'un traitement ou d'une
maladie

Diapositive 156

III. MATERIEL

(1/2)

Corps de pompe à usage unique (vacutainer

).

Aiguille à monter s'adaptant au corps de pompe.

Aiguille épicroténienne équipée d'une tubulure et d'un adaptateur au corps de pompe.

Seringue stérile et aiguille.

Tube(s) de prélèvement sous vide.

Antiseptique ou alcool modifié à 70°.

Compresse non stériles ou boules de coton.

Garrot.

Diapositive 157

III. MATERIEL

(2/2)

Protection papier absorbant à usage unique.

Gants non stériles à usage unique.

Etiquettes laboratoire d'identification patient.

Bons d'analyses laboratoire, avec pochette de transport.

Sac à élimination des déchets.

Conteneur à déchets contaminés piquants et tranchants.

Désinfectant de surface et

chiffonnette

.

Nécessaire à l'hygiène des mains.

Diapositive 158

IV. REALISATION

DU

SOIN

(1/4)

Vérifier la prescription médicale.

Vérifier la concordance entre la prescription médicale et le choix des tubes d'analyses.

Prévenir le patient du soin.

Réunir le matériel après vérification des dates de péremptions et de l'intégrité des emballages.

Placer le matériel sur une surface propre et désinfectée au préalable.

Installer le réniforme et le container à déchets contaminés piquants loin du matériel propre.

Respecter le triangle d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie.

Prélever le sang du côté opposé à la perfusion intraveineuse.

Mettre le garrot 10 cm au-dessus du point de ponction et vérifier la présence d'un pouls artériel en contrebas (pouls radial), sinon, risque de thrombose

.

Diapositive 159

IV. REALISATION DU SOIN

(2/4

)

La

pose du garrot durant plus de 3 minutes peut modifier les résultats d'analyse puisqu'il y a un risque d'hémolyse des globules.

Choisir la veine à ponctionner.

Favoriser la vasodilatation de la veine, ce qui rend le geste plus facile :

Demander au patient de serrer le poing.

Mettre le bras en déclive.

Mettre la protection sous la zone de ponction.

Effectuer un lavage antiseptique des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains.

Mettre les gants non stériles.

Pratiquer une antisepsie de la peau :

Procéder en partant du bas vers le haut pour favoriser un afflux de sang.

Ne jamais repasser à un même endroit.

Utiliser une compresse par passage puis la jeter dans le sac à déchets

.

Diapositive 160

IV

. REALISATION DU SOIN

(3/4)

Introduire

l'aiguille biseau vers le haut, dans la veine.

Maintenir et immobiliser le corps de prélèvement avec le pouce et l'index de la main dominante

Introduire les tubes de prélèvements avec la main non dominante selon un ordre précis

Pendant que le tube se remplit, homogénéiser le tube précédent par des retournements lents

Tubes avec gels : 5

retournements

Autres tubes : 8 à 10

retournements

Enlever le tube du corps de prélèvement

Tout

en maintenant l'aiguille, desserrer le garrot d'une main

Diapositive 161

IV. REALISATION DU SOIN

(4/4)

Retirer

l'aiguille et comprimer le point de ponction pour éviter un hématome.

Jeter immédiatement le corps de pompe et l'aiguille dans le container à déchets contaminés piquants.

Enlever et jeter les gants.

Mettre un pansement.

Eliminer les déchets et désinfecter le matériel utilisé.

Effectuer un lavage simple des mains ou effectuer un traitement hygiénique.

Vérifier la concordance des étiquettes et de l'identité du patient puis étiqueter les tubes d'analyses, remplir les bons d'analyse et acheminer les tubes au laboratoire d'analyse.

Ranger le matériel et noter le soin

Diapositive 162

V-COMPLICATIONS

Hématome au point de ponction : bien comprimer le point de ponction après le prélèvement.

Défaut de reflux du sang : non ponction de la veine, transperçement de la veine, veine trop ou pas assez comprimée.

Douleur.

Malaise vagal : stopper le soin, mettre le patient en déclive.

VI- SURVEILLANCE

Surveillance du point de ponction

Diapositive 163

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 164

PERFUSION INTRAVEINEUSE

DEFINITION

La perfusion périphérique ou intraveineuse est l'introduction d'un cathéter court dans une veine superficielle qui permet d'administrer chez un patient des solutés et/ou des médicaments de façon continue ou

discontinue

II. INDICATIONS

Disposer

d'une voie d'abord veineuse en cas d'urgence et de réanimation

Administration

de

médicaments

Apport

hydrique et/ou

électrolytique

Transfusion

de produits

sanguins

Alimentation

parentérale

Diapositive 165

III. CONTRE-INDICATIONS

Anémie sévère

Anasarque

Œdème

aigu des

poumons

Insuffisance

cardiaque

grave

Insuffisance rénale

Dès

que la voie orale est possible

Diapositive 166

IV.

PREPARATION

DU SOIN

Préparation psychologique du malade

Elle est indispensable dans tous les
soins

Elle

permet de rassurer le malade, de le mettre en confiance, et d'obtenir son adhésion et sa
collaboration

Diapositive 167

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 168

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 169

Matériel

(2/3)

Compresse

stériles.

Produits pour l'antisepsie.

Trocart.

Sparadrap.

Seringue stérile.

Coton hydrophile.

Produits médicamenteux.

Un chariot.

Grand plateau stérile.

Petit plateau stérile.

Sérum physiologique ou eau stérile

.

Diapositive 170

Matériel

(3/3)

Gants

:

Gants non stériles

s'il n'y a pas de palpation du point de ponction après l'antisepsie.

Gants stériles

s'il y a palpation du point de ponction après l'antisepsie cutanée.

Pansement occlusif stérile transparent.

Tondeuse si possible.

Sac à élimination des déchets (papier et matériel non contaminé) ou haricot.

Sac à élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux ou poubelle.

Conteneur à déchets contaminés piquants et tranchants. Ou boîte de sécurité.

Désinfectant de surface et

chiffonnette

.

Nécessaire à l'hygiène des mains.

Diapositive 171

Technique du
soin

(1/4)

Vérifier la prescription médicale.

Prévenir le patient.

Effectuer un lavage simple des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains.

Réunir le matériel après vérification des dates de péremptions et de l'intégrité des emballages.

Installer les poubelles de tri des déchets au pied du lit du patient.

Mettre le garrot.

Choisir la veine à perfuser : préféré les veines radiales et cubitales aux veines du dos de la main trop fragiles ou aux veines du pli du coude que l'on réserve aux situations d'urgence.

Diapositive 172

Technique du soin

(2/4)

Favoriser

la vasodilatation ce qui rend le geste plus facile :

Demander au patient de serrer le poing.

Mettre le bras en déclive.

Si besoin, dépiler la zone à ponctionner avec une tondeuse ou aux ciseaux, ne pas raser.

Protéger le lit en plaçant une alèze sous la zone de ponction.

Effectuer un lavage antiseptique des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains.

Mettre les gants stériles.

Pratiquer une antisepsie de la peau en 4 temps :

Aller de l'intérieur vers l'extérieur.

Ne jamais repasser à un même endroit.

Utiliser une compresse par passage puis la jeter dans le sac à déchets contaminés

Diapositive 173

Technique du soin

(3/4)

Préparer

la perfusion : purger la tubulure et disposer la poche sur le pied à perfusion.

D'une main, tendre la peau et maintenir la veine, de l'autre main, introduire le cathéter biseau vers le haut.

Desserrer le garrot.

Retirer le mandrin et l'éliminer immédiatement dans le container à déchets contaminés piquants.

Adapter la tubulure au

cathlon

.

Diapositive 174

Technique du soin

(4/4)

NB:

Ne

jamais piquer :

sur

une peau

lésée

sur

une fistule artério

veineuse

du

côté d'un curage

axillaire

sur

un membre

paralysé

-• &÷N-vW" ÆR 6—FR FR öæ7F—öâ vec le pansement occlusif stérile transparent.

-•`érifier la bonne position du cathéter en réalisant un reflux (mettre la poche pour perfusion plus bas que le point de ponction et vérifier la venue du sang dans le cathéter).

Diapositive 175

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 176

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 177

V-

RISQUES ET COMPLICATIONS

Infection.

Œdème.

Lymphangite.

Hématome.

Obstruction de la perfusion.

Adhérence du mandrin.

Diapositive 178

VI-

SURVEILLANCE

ET

EVALUATION

Point

de

ponction

Vérifier

l'absence de signe d'inflammation : douleur, rougeur, chaleur,
œdème

Vérification

de l'écoulement de la

perfusion

Vérifier

le

débit

Surveillance

de la température.

NB : Changement

de cathéter veineux

court

toutes les 72 heures

Diapositive 179

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 180

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 181

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 182

INJECTION LENTE PAR DISPOSITIF INTRAVEINEUX

I- DEFINITION

L'injection lente par dispositif intraveineux (injection intra-tuyaux) est l'administration d'un produit médicamenteux présenté sous forme injectable par la voie d'un dispositif intraveineux déjà posé (cathéter).

II- INDICATION

Nécessité d'une action rapide.

Diapositive 183

III- MATERIEL

Un plateau stérile

Produit à injecter.

Présentation du produit :

Seringue stérile de 1 ml à 20 ml en fonction de la quantité du produit à injecter

.

Poche pour perfusion avec tubulure.

Bouchon stérile pour site d'injection (robinet).

Compresses stériles.

Antiseptique.

Réniforme (haricot).

Sac à élimination des déchets.

Conteneur à déchets contaminés piquants et tranchants.

Désinfectant de surface et

chiffonnette

Nécessaire

à l'hygiène des mains

Diapositive 184

IV- TECHNIQUE

DU

SOIN

(1/2)

La manipulation de la ligne de perfusion, du robinet ou d'une rampe de perfusion se fait toujours après un lavage antiseptique des mains.

Vérifier la prescription médicale.

Vérifier la compatibilité du traitement à injecter et le traitement en cours d'administration par la perfusion.

Préparer en respectant les règles de préparation, le produit à injecter dans une poche pour perfusion ou dans une seringue.

Prévenir le patient du soin.

Effectuer un lavage simple des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains

.

Diapositive 185

IV- TECHNIQUE DU SOIN

(2/2)

Disposer

le matériel après vérification des dates de péremptions et de l'intégrité des emballages.

Installation sur une surface propre et désinfectée au préalable.

Installer le réniforme loin du matériel propre.

Vérifier le reflux sanguin de la perfusion : ouvrir le débit de la perfusion au maximum, mettre la poche du soluté en déclive (plus bas que le point de ponction), - Vérifier au niveau du cathlon

la présence d'un reflux sanguin, remettre la poche et le débit de la perfusion.

Effectuer un lavage antiseptique des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains

.

Purger la tubulure.

Diapositive 186

INJECTION PAR
SERINGUE

(1/2)

:

Adapter la seringue à la voie d'injection du robinet.

Ouvrir la voie allant vers le patient et fermer la voie de la perfusion.

Injecter doucement le produit tout en observant la réaction du malade

Refermer la voie d'injection et rouvrir la voie de la perfusion.

Désadapter la seringue de la voie d'injection.

Mettre un nouveau bouchon stérile en le manipulant avec une compresse stérile.

Jeter et désinfecter le matériel.

Effectuer un lavage simple des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains

Adapter l'embout de la tubulure en le manipulant avec une compresse stérile imbibée d'antiseptique

Diapositive 187

-

INJECTION PAR SERINGUE

(2/2

)

:

Adapter

l'embout de la tubulure en le manipulant avec une compresse stérile imbibée d'antiseptique.

Ouvrir le robinet.

Régler le

débit

de la perfusion.

Clamper la perfusion quand le produit est administré.

Refermer la voie d'injection.

Désadapter l'embout de la tubulure en le manipulant toujours avec une compresse stérile imbibée.

Mettre un nouveau bouchon stérile en le manipulant avec une compresse stérile

.

Jeter et désinfecter le matériel.

Effectuer un lavage simple des mains ou effectuer un traitement hygiénique.

Diapositive 188

V- RISQUE

ET COMPLICATION

Choc anaphylactique : réaction allergique.

VI- SURVEILLANCE

ET EVALUATION

Surveillance du point de ponction du cathéter.

Surveillance du débit.

Surveillance des réactions possibles du patient pendant et après l'injection.

Diapositive 189

VII-

LES

INCIDENTS ET ACCIDENTS LIES AUX INJECTIONS

Les incidents et les accidents liés aux erreurs

Les erreurs de médicaments peuvent être redoutables pour cela il faut :

Bien vérifier le nom du médicament

à injecter

(la dose prescrite et la dose de

l'ampoule)

Vérifier le nom du malade et non le numéro du lit.

Ne jamais préparer dans un même plateau plusieurs injections pour des malades différents.

Préparer l'injection au lit du malade.

Si l'injection est préparée en salle de soin, n'en préparer qu'une à la fois.

Diapositive 190

Les erreurs dans les modes d'injection

Un produit injecté par voie intra veineuse alors qu'il devrait être parfois intra musculaire ou sous cutané peut déclencher un état de choc.

Un produit injecté par voie IM ou sous cutané alors qu'il devrait l'être par voie intraveineuse, peut provoquer une escarre...

Bien vérifier le mode d'injection sur la prescription et sur l'ampoule, en cas de doute se renseigner auprès du médecin traitant avant de faire l'injection

.

Incidents et accidents liés au mauvais choix du lieu d'injection

L'injection au niveau du nerf sciatique provoque une douleur immédiate mais peut entraîner par la suite

une sciatique.

L'injection sur l'os peut entraîner la rupture de l'aiguille dans le corps.

Diapositive 191

Fautes d'asepsie

doigts mis sur l'embout ou sur le piston, aiguille ayant touché l'extérieur de l'ampoule ou le chariot
mauvaise désinfection de la peau etc.

Ces fautes d'asepsie favorisent l'apparition d'abcès souvent profond lors de l'injection intramusculaire et nécessite une incision chirurgicale.

Mauvaises stérilisations

Une stérilisation défectueuse peut favoriser l'apparition :

D'abcès

D'hépatite virale

Diapositive 192

Incidents et accidents liés au médicament lui-même

.

La mauvaise résorption du produit

Les substances huileuses se résorbent difficilement. Il peut se produire une collection. Pour prévenir cet accident il faut varier les points d'injection.

Les réactions allergiques

réactions locales (urticaire, œdème)

réactions générales (choc anaphylactique)

la prévention du choc anaphylactique

La prévention du choc anaphylactique est possible en refusant toute injection à un malade déjà sensibilisé au produit de par l'interrogatoire et il faut rechercher des signes d'intolérance :

Prurit, urticaire œdème au point de piqûre au cours d'un traitement précédent, malaise général, céphalée

Diapositive 193

Le traitement du choc anaphylactique

Il doit être immédiat :

injection IV d'hydrocortisone ou de
soludécadron

®

une réanimation doit être entreprise aussi tôt suivant l'état du malade : respiration artificielle,
massage cardiaque externe, oxygénation

...

LA CCC

La communication pour le changement de comportement consiste à donner des conseils en rapport
avec le soin au client :

L'hygiène corporelle (se laver après une injection)

Éviter l'automédication

Consulter toujours le personnel médical en cas d'anomalie

Éviter de fréquenter les infirmeries de quartier

Déconseiller au malade de masser le site d'injection avec de l'eau chaude

Déconseiller le massage du site avec des
chaussures

NB

: Les injections ne doivent se faire que par nécessité, il faut toujours privilégier la voie orale si
possible

Diapositive 194

SÉCURITÉ DES INJECTIONS ET
IMPACT

DES INJECTIONS A RISQUE

I- DÉFINITION

DE LA NOTION DE SÉCURITÉ DES INJECTIONS

SECURITE DES INJECTIONS

C'est l'ensemble des dispositions et des pratiques qui concourent à faire des injections nécessaires, sans danger, avec du matériel stérile détruit par la suite selon les normes de sécurité.

GESTION DES DECHETS MEDICAUX

C'est un processus visant à garantir l'hygiène des établissements sanitaires, la sécurité de l'agent de santé, du client, de la communauté et de l'environnement.

Ce

processus inclut :

le tri des déchets

la collecte des déchets aux points de stockage

Le stockage des déchets

Le transport des déchets

La destruction des déchets

Diapositive 195

C- RISQUE

INFECTIEUX

C'est la possibilité de contamination des suites de l'utilisation du matériel d'injection souillé.

D- CONTROLE

ET PREVENTION DE L'INFECTION

C'est la maîtrise de tous les facteurs pouvant entraîner une infection tant au niveau des personnels soignants et des clients que de la communauté et l'environnement

Diapositive 196

II- PRINCIPES

DE

BASE

(1/3)

Utiliser un système seringue-aiguille autobloquant stérile pour chaque injection.

Utiliser une seringue et une aiguille jetables pour reconstituer chaque produit injectable.

Eviter de contaminer le matériel d'injection.

Préparer chaque injection dans un lieu propre, prévu à cet effet et où il y a peu de risques de contamination par du sang ou des liquides organiques

.

Percer toujours le septum des flacons multi dose avec une aiguille stérile.

Ne pas laisser d'aiguille plantée dans le bouchon

Diapositive 197

II- PRINCIPES DE BASE

(2/3)

Se

protéger les doigts avec un petit tampon de gaze pour casser les ampoules.

Jeter toute aiguille qui a été en contact avec une surface non stérile (mains, surfaces environnantes).

Anticiper et prendre des précautions pour éviter un mouvement brusque du patient pendant et après l'injection.

Pour éviter de se piquer, ne pas recapuchonner

les aiguilles usagées et

les déposer directement dans un réceptacle de sécurité.

Jeter les seringues et aiguilles usagées dans un réceptacle de sécurité au point d'utilisation et le fermer hermétiquement quand il est plein (ne pas transvaser le contenu ni trop remplir le réceptacle).

Diapositive 198

II- PRINCIPES DE BASE

(3/3)

Transporter

les réceptacles de sécurité fermés dans un lieu sûr. Ne pas les ouvrir, les vider ou les réutiliser.

Éliminer les déchets des injections selon un procédé efficace et respectueux de l'environnement.

Éviter les accidents dont pourrait être victime le personnel chargé d'éliminer les déchets.

Ne pas mettre de flacons vides dans les réceptacles de sécurité car ils risqueraient

d'exploser en brûlant.

Ne mettre que du matériel d'injection usagé dans les réceptacles de sécurité.

Ne pas y mettre de flacons vides, de coton, de compresses, etc

.

Diapositive 199

PRATIQUES À RISQUE D'UNE INJECTION

Les pratiques à risque sont liées au non respect des conditions de sécurité des injections selon le type de population, les pratiques des injections, représentent des risques potentiels que le praticien se doit d'éviter

Diapositive 200

Pratiques à risque pour les personnes qui reçoivent les injections

.

Réutiliser une seringue ou une aiguille

.

Changer l'aiguille, mais réutiliser la seringue.

Faire une injection lorsqu'il y a des alternatives plus sûres.

Tenter

de stériliser et de réutiliser une seringue jetable.

Faire bouillir le matériel d'injection dans un récipient ouvert.

Utiliser uniquement des désinfectants sur les seringues et les aiguilles

pour

les préparer à la réutilisation.

Diapositive 201

Charger les seringues avec des doses multiples et faire des injections à plusieurs personnes.

Appuyer sur le point de saignement avec du matériel usagé ou le doigt.

Laisser une aiguille plantée dans le flacon pour prélever, les doses supplémentaires.

Toucher l'aiguille avant
l'utilisation.

Stériliser et réutiliser une seringue jetable.

Désinfecter les seringues et les aiguilles pour les préparer à la réutilisation

Disposer plusieurs seringues chargées de différents clients dans un même plateau.

Utiliser un autre

désinfectant : le parfum, le 'koutoutou'

Diapositive 202

Pratiques à risque pour les agents de santé

Recapuchonner

les aiguilles

Détacher l'aiguille de la seringue avec la main

Placer les aiguilles sur une surface et les transporter sur une certaine distance avant de les jeter

Aiguiser les aiguilles émoussées ou bloquées pour les réutiliser

Plonger la main dans une grande quantité de seringues ou d'aiguilles (pour nettoyer ou trier les déchets)

Diapositive 203

Pratiques à risque pour la communauté

Laisser les seringues usagées dans des endroits où les enfants peuvent avoir accès.

Donner ou vendre des seringues déjà utilisées.

Laisser les seringues usagées dans des endroits accessibles au public.

Diapositive 204

OBSTACLE A UNE INJECTION SÉCURISÉE

Obstacles liés aux prestataires de soins

.

Méconnaissance : manque d'information et de formation des agents.

Incompétence : absence d'habiliter pour réaliser une injection sécurisée.

Imprudence : non respect des consignes pour une injection sécurisée été
la négligence de

l'agent

Inconscience de l'agent.

Obstacles liés aux matériels

Matériel périmé.

Matériel défectueux : aiguilles usées qu'on aiguisé dans le but de les réutiliser.

Matériel insuffisant : indisponibilité de seringues autobloquantes qui
entraîne la réutilisation des seringues usées.

Seringue à utilisation multiple.

Matériel inadapté ; seringue à utilisation complexe

Diapositive 205

CONSÉQUENCES DES INJECTIONS A RISQUE

Toute injection dangereuse cause des infections, des lésions et des problèmes liés à la substance administrée.

Les infections les plus graves et les plus courantes, transmises par les injections à risque sont :

l'hépatite B,

l'hépatite C

le VIH/SIDA

le virus d'Ebola.

Diapositive 206

II / Incidents et accidents induits par le prélèvement sanguin

Incidents

:

Hématomes

Causes : garrot trop serré, veines invisibles, ponctions répétées etc.

CAT : pansement alcoolisé compressif

Malaise vagal

Causes : angoisse, jeun, etc.

CAT : garder le calme et retirer l'aiguille, comprimer le point de ponction avec un tampon pst compressif, suite voir CAT

syncope

Accidents

Piqûre d'un nerf

CAT :

Diapositive 207

LE THERMOMETRE MEDICAL

DEFINITION

Le thermomètre médical est un appareil qui sert à mesurer et à afficher la valeur de la température du corps humain

L'unité de mesure de la température est le degré Celsius
(°C)

Diapositive 208

II.LES DIFFERENTS MODELES DE THERMOMETRE

Il y a plusieurs types de thermomètre qui sont :

le

thermomètre au gallium ou au

galinstan

(= médical)

le

thermomètre à mercure (

proscrit

)

le

thermomètre à

carbone

le

thermomètre

électronique:

- le

thermomètre

frontal

- le

thermomètre à infra

rouge

- le

thermomètre

auriculaire

- le

thermomètre

buccal

- le

thermomètre

sucette

- le

thermomètre digital.

Cependant nous allons décrire ceux qui sont utilisés dans nos services

Diapositive 209

2-1 Le thermomètre médical

C'est le thermomètre au gallium qui est communément appelé le thermomètre médical. Il se compose d'un tube de verre fermé, fixé à une règle graduée allant de 35°C à 42°C et d'une extrémité renflée (cuvette) contenant du mercure. À l'intérieur se trouve un tube très fin dans lequel le mercure remonte quand il est chauffé

Diapositive 210

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 211

2-2 Le thermomètre électronique

C'est un appareil qui fonctionne selon un système électrique et comporte sur une de ses faces un tableau d'affichage

automatique, la

valeur de la température.

Un

signal sonore

annonce

l'affichage de la température

Diapositive 212

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 213

III LES VARIATIONS DE LA TEMPERATURE

L'équilibre entre la production et la perte de température par l'organisme s'appelle
la

thermorégulation

Elle

se fait naturellement mais il peut arriver que des éléments perturbent cet équilibre provoquant ainsi
une production excessive de chaleur par l'organisme ou un refroidissement de celui-ci.

Cette

variation de température peut être physiologique ou pathologique

Diapositive 214

3-1

Les variations physiologiques

Elles dépendent de nombreux facteurs :

le climat

l'heure (4h-8h T° basse, 16h - 18h T° élevée)

la digestion (repas abondant T° élevée, diète T° basse)

le travail physique et intellectuel

les émotions, le repos

l'âge (nouveau né température irrégulière, vieillard température en dessous de la normale)

Diapositive 215

3-2 Les variations pathologiques

Elles sont de deux natures :

l'hyperthermie ou l'

hyperpyrexie

=

élévation de la température au dessus de

37,5°C.

C'est le cas dans le paludisme ;

- l'hypothermie ou l'

hypopyrexie

= baisse de la température en dessous de 36°C. C'est le cas dans le choléra

Diapositive 216

IV

LES DIFFERENTS SITES DE PRISE DE LA TEMPERATURE

Dans les cavités

naturelles:

le rectum

le vagin

la bouche

l'oreille

La température ainsi obtenue est dite température des cavités naturelles

Diapositive 217

En

surface du corps:

le front

le creux axillaire

la région sous mammaire

la région inguinale

Le pli du coude

le creux du genou

La température ainsi obtenue est dite température des surfaces cutanées

Diapositive 218

V- LES TECHNIQUES DE PRISE DE TEMPERATURE

5-1

La température

axillaire

(1/2)

Si

c'est un thermomètre médical à mercure, faire descendre le mercure dans la cuvette en le secouant ;

Si

c'est un thermomètre

électronique

le

mettre

à

zéro

t

amponner

l'aisselle avec du coton ou une compresse pour enlever la sueur,

installer le malade (coucher sur le dos ou sur le côté),

placer la cuvette du thermomètre au creux de l'aisselle et serrer le bras sur le thermomètre contre le thorax

Diapositive 219

(2/2

)

-

retirer

le thermomètre au bout de 5 à 10

minutes

lire la température en inclinant de profil le

thermomètre

Ajouter 5/10

ème

de degré pour obtenir la température des cavités

naturelles

noter avec

un stylo bleu

la température sur la feuille de température ou la feuille de surveillance

Diapositive 220

Contre-indications

:

personnes maigres

nouveau-nés

enfants

Diapositive 221

5-

2 La température
rectale

(
1/2
)

S'

assurer

qu'il n'a pas envie d'aller à la selle en ce
moment

installer le malade sur le côté, la cuisse supérieure légèrement repliée sur
l'abdomen

Si

c'est le thermomètre médical faire descendre le mercure dans la cuvette en le secouant, si c'est un
thermomètre électronique le mettre à

zéro

lubrifier légèrement le
thermomètre

Diapositive 222

(2/2)

introduire

le thermomètre dans l'anus et le pousser doucement dans le rectum

jusqu'à 4 cm

environ ;

si

le malade sait le placer laisser le faire sous votre surveillance,

laisser le thermomètre en place pendant 3 minutes,

essuyer le tube de verre s'il est sale avec du coton imbibé d'eau savonneuse ou un antiseptique (dakine),

lire la température en inclinant de profil le thermomètre,

noter avec

un stylo bleu

la température sur la feuille de température ou la feuille de surveillance

Diapositive 223

Contre-indications

Abcès de la région anale

Infection intestinale

Etranglement hémorroïdaire

Intervention sur le rectum

Diapositive 224

La température buccale

Thermomètre

sucette

(

1/2

)

Surtout avec le thermomètre électronique à cause des accidents qui peuvent survenir avec le mercure.

Il

ne doit pas se prendre immédiatement après le repas ou après la prise d'une boisson chaude ou froide

le malade peut rester assis ou couché

mettre le thermomètre à zéro

Diapositive 225

(2/2)

placer

l'extrémité du thermomètre sous la langue

le malade doit s'abstenir de parler

laisser le thermomètre en place pendant 3 minutes

le retirer dès le signal sonore

lire la température affichée et la notée avec un

stylo bleu

sur la feuille de température ou la feuille de surveillance

Diapositive 226

Contre indications

:

Malade délirant

Enfant malade atteint de rhinite

NB :

noter avec un

stylo bleu

la température

sur la feuille de température ou la feuille de surveillance,

nettoyer méticuleusement le thermomètre avec du coton et de l'eau savonneuse ou un antiseptique
le sécher et le ranger

Diapositive 227

Le thermomètre médical doit être individuel pour éviter les contaminations.

Privilégier toujours la voie rectale s'il n'y a pas de contre indications à cette voie.

Faire toujours la communication pour le changement de comportement (C.C.C.) et le remercier avant de prendre congé de lui

.

Diapositive 228

CONCLUSION

La température est un élément déterminant du diagnostic donc sa prise doit faire l'objet d'une attention particulière. C'est pourquoi, il est important de savoir utiliser le thermomètre et de connaître les différentes techniques de prise de la température

.

Diapositive 229

LA TEMPERATURE

INTRODUCTION

La température est une grandeur physique qui mesure le degré de chaleur d'un corps ou d'un milieu

Lorsque deux corps sont placés dans une enceinte adiabatique, le corps le plus chaud cède de la chaleur au corps le plus froid, jusqu'à ce que les deux corps aient la même température (équilibre thermique)

La température se mesure à l'aide d'un thermomètre

Diapositive 230

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 231

DEFINITION

La température du corps humain est le degré de chaleur stocké par l'organisme

Elle est soit :

physiologique

: normale

pathologique

: due à la maladie

La température se mesure à l'aide d'un thermomètre médical et s'exprime en degré Celsius (°C)

La température normale au repos se situe entre 36,5°C et 37 °C le matin et entre 37°C et 37°5 le soir

Diapositive 232

II) LES VARIATIONS DE LA TEMPERATURE

Elles sont de deux ordres :

physiologiques

pathologiques

Diapositive 233

Les variations physiologiques

Les variations physiologiques de la température sont dues à plusieurs facteurs :

l'activité physique

: travail physique (effort musculaire), travail intellectuel,

l'âge

(chez les enfants et prématurés on observe de grands écarts de température).

le sexe

: la température augmente de 2 à 3 degrés lors de chaque cycle menstruel pendant la période d'ovulation.

-

la digestion

Diapositive 234

Les variations pathologiques

L'hyperthermie :

C'est l'élévation de la température du corps au-dessus de 37,5°C

L'hypothermie :

baisse de la température du corps au dessous de 36,5°C

.

Diapositive 235

III)

RÔLE

DE

L'AGENT DE SANTE

Hyperthermie

Prendre la température et la noter

Déshabiller

le malade

Faire un enveloppement humide

Lui donner à boire fréquemment

Faire un bain avec de l'eau de réseau (ou à – 2°C de la température mesurée)

Diapositive 236

2- Hypothermie

Prendre régulièrement la température et noter

Habiller chaudement le client et le couvrir

Mettre une bouillotte auprès du client

Diapositive 237

LES METHODES DE CORRECTION THERMIQUE

INTRODUCTION

Elles visent à corriger les hypo et hyperthermies afin d'en limiter les complications.

Les soins de correction des hypothermies visent à réchauffer progressivement et en toute sécurité la personne soignée.

Les soins de correction de l'hyperthermie visent à refroidir la personne progressivement en toute sécurité.

Dans ce cours nous ne parlerons que de la bouillotte qui sera utilisée pour réchauffer et de la vessie de glace pour refroidir

Diapositive 238

A) LA BOUILLOTE

DEFINITION

Une bouillotte est un

récipient

étanche servant à contenir de l'

eau

chaude, généralement utilisé pour tenir une personne au chaud, notamment lorsque celle-ci est dans son

lit

ou malade. Elle peut être utilisée simplement pour réchauffer le lit avant de se coucher. Les bouillottes sont généralement faites en

caoutchouc

.

Diapositive 239

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 240

TECHNIQUE

Remplir à moitié la bouillotte avec de l'eau à 80°C chez l'adulte.

Chasser l'air avant de fermer en appuyant sur la poche.

Fermer et vérifier l'étanchéité.

Envelopper la bouillotte d'un morceau de tissu.

Disposer la bouillotte soit à dix centimètres des pieds de la personne soit sur une partie précise du corps de la personne.

Après usage égoutter la bouillotte, la laisser sécher et désinfecter si nécessaire

Diapositive 241

II- ELEMENTS
DE SURVEILLANCE

La

peau du malade

La température

du malade

Diapositive 242

B- VESSIE DE GLACE

INTRODUCTION

C'est une poche en caoutchouc, où l'on introduit des glaçons

La thérapie par le froid consiste à appliquer le froid pour soulager un patient

Diapositive 243

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 244

I-

INDICATIONS

Médicales

:

(1/2)

Hémorragies

Méningites

Soulager

une

douleur

Diminuer

une

enflure

Fièvre

Diapositive 245

Chirurgicales

(2/2

)

Limiter un épanchement de sang dans les tissus

Appendicites

Salpingites aiguës

Fracture du crâne

Péritonite

Diapositive 246

II- MATERIEL

Vessie de glace

Glaçon ou glace pilée

Talc

Alaise ou linge de dimension adaptée à la région à traiter ou une serviette

Diapositive 247

III-

TECHNIQUE

Remplir la poche ou la vessie aux 2/3 avec des glaçons ou de la glace pilée

Entourer

la poche avec un linge

Talquer la surface cutanée à traiter et y placer la poche

Maintenir la poche en place avec une bande souple et élastique renouveler aussi souvent que nécessaire selon la prescription médicale

N.B

: ne jamais appliquer la vessie de glace au niveau du cœur

Diapositive 248

IV-

ELEMENTS DE SURVEILLANCE

La température du malade

Recherche d'une diminution, d'une absence ou d'une augmentation de la douleur

Diapositive 249

LA FEUILLE DE TEMPERATURE

Diapositive 250

DEFINITION

La feuille de température est une feuille spéciale ou document que l'on trouve au pied du lit du malade ou dans le dossier du malade

comportant un ensemble de renseignements ou d'informations relatifs au malade, au médecin traitant et à la structure d'accueil

.

Diapositive 251

La feuille de température permet de suivre régulièrement et facilement l'évolution et l'état du malade

Diapositive 252

DESCRIPTION DE LA FEUILLE DE TEMPERATURE

(1/2)

La feuille de température est une feuille de dimension variable selon le service.

Elle comprend :

une partie non quadrillée ou entête qui renseigne sur le type de structure et le service d'accueil du malade

une partie quadrillée avec 4 sous-parties :

I

a

première

est relative aux renseignements généraux du malade et au médecin traitant

Diapositive 253

DESCRIPTION DE LA FEUILLE DE TEMPERATURE

(2/2)

La deuxième
est réservée aux
traitements et aux dates

La troisième
est destinée au
bilan et aux différentes constantes

La quatrième
est consacrée à la
surveillance de certains paramètres.

Ces paramètres varient en fonction du service et de la pathologie.

Exemples

:

le poids est un élément capital et indispensable chez le malade cardiaque et l'enfant en
pédiatrie

|

a
surveillance des selles chez le malade cholérique.

|

a
surveillance des
urines chez le malade diabétique.

Diapositive 254

ETUDE DETAILLEE DES DIFFERENTS TRAITS

La feuille de température comprend deux types de traits

les traits verticaux

Les traits verticaux gras divisent les différentes colonnes journalières.

Les traits verticaux fins divisent chaque colonne journalière en deux parties égales représentées par les lettres M (matin) et S (soir).

Traits horizontaux

Des traits horizontaux gras qui servent de point de repère pour chaque constante et délimitent les intervalles entre différentes variations des constantes.

Exemple : 37°C

Diapositive 255

ETUDE DETAILLEE DES DIFFERENTS TRAITS

Des traits horizontaux fins qui divisent les intervalles compris entre deux traits horizontaux gras en cinq petites rangées de différentes

valeurs Ainsi on note:

I

a

respiration : la valeur est de 1 mouvement respiratoire à 1 mouvement respiratoire

la tension artérielle: la valeur est de 1 à 1 mm Hg

I

a

température est de 2 à 2/10 de degré

le

pouls est 3 à 3

pulsations

I

a

diurèse est de 100 à 100 ml

Diapositive 256

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES COURBES

Les courbes sont tracées avec les différentes couleurs pour éviter de les confondre.

Par convention nous avons :

Constante

C

Couleur F

FIGURE

Température

Bleu Courbe

Tension

artérielle Rouge

Histogramme

hachuré

Pouls Rouge Courbe

Urine Jaune Histogramme plein

Respiration V

ert Escaliers

La valeur

normale de l'urine

varie entre 1,2 à 1,5 litre

par jour

Diapositive 257

La date d'une intervention chirurgicale
est indiquée par une
flèche en
rouge

On indiquera également par une flèche l'ablation de drain et de fils

.

Diapositive 258

Les différentes sortes de courbes de température

Courbes en plateau

Caractérisée par une hyperthermie régulière se maintenant sur plusieurs jours.

Fièvre rémittente

Elle est constituée d'accès fébriles rapprochés avec température n'arrivant pas à atteindre la normale

Fièvre intermittente

Succession régulière d'accès fébrile : tous les trois jours (fièvre tierce) ou tous les quatre jours (fièvre quarte) mais entre lesquels la température redescend le soir à la normale.

Diapositive 259

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 260

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 261

(pas de texte extrait sur cette diapositive)